

26 - 02- La lithiase de la vésicule biliaire et ses complications - Pr. Benelkhaïat

... à la face inférieure du foie, exactement à la face inférieure des segments 4 et 5. Donc elle a la forme d'une poire. Elle est connectée à la voie biliaire principale par le canal cystique. Il faut connaître la physiologie de la sécrétion biliaire.

La bile, elle est formée, synthétisée au niveau du parenchyme hépatique. On sait très bien qu'elle va couler vers l'intestin par l'intermédiaire des voies biliaires intrahépatiques. Ensuite, les canaux biliaires droit et gauche vont converger, former la voie biliaire principale.

Et selon l'état physiologique, si le patient est agent, cette bile va être stockée, elle va pénétrer la visicule biliaire. Et si le patient prend son repas, la contraction de la visicule biliaire emmène la bile dans l'intestin. Et la bile a un rôle très important dans l'absorption de certaines vitamines, notamment la vitamine K au niveau de l'illium.

Elle a un rôle dans la digestion et l'absorption des graisses. On va voir en détail les différents mécanismes qui ont résulté d'un problème, d'un dérèglement dans la sécrétion de la bile. Également, il faut connaître les symptômes que produit la présence d'un calcul.

Initialement, c'est une obstruction mécanique des calculs qui vont venir se bloquer au niveau du siphon, du col et de la visicule biliaire, ou bien au niveau du canal cystique. Puis, par la suite, vont résulter des surinfections après le phénomène de stase de la bile, ce qui donne des complications telles que la colicystite ou bien l'ongite. Comme introduction, on va dire que la litiase de la visicule biliaire, c'est la présence de calculs dans les voies biliaires.

C'est une infection très fréquente. C'est un motif de consultation que tout médecin, praticien doit savoir comment poser le diagnostic, comment manager le diagnostic, la demande des examens complémentaires. Mais aussi, il faut savoir reconnaître les complications qui peuvent être graves telles que la migration de ces litiases à travers le canal cystique dans la voie biliaire principale, mais aussi d'autres complications telles que le franchissement des litiases dans le sphincter body qui va déclencher ce qu'on appelle la pancréasite aiguë biliaire.

Les complications peuvent résulter soit de l'obstruction des voies biliaires, mais aussi de la migration, c'est-à-dire le passage à travers le sphincter body. Le traitement est essentiellement chirurgical. Je ne peux pas démarrer ce cours sans vous citer un peu d'historique concernant le traitement, essentiellement concernant la maladie.

Certains patients présentent des malformations au niveau du collet ou des visicules biliaires à diaphragme et tout ceci peut favoriser l'apparition de micro-cristaux qui peuvent donner des litiases par la suite. Une sécrétion de mucus abondante, le mucus est sécrété par la muqueuse de la visicule biliaire et il constitue la matrice des calculs. Donc toute anomalie dans la visicule biliaire peut aussi favoriser l'apparition des calculs de la visicule biliaire.

Sur le plan clinique, toute irritation et infection de la visicule biliaire va donner des douleurs, ce qu'on appelle la colique hépatique. Mais en fait c'est une fausse appellation parce qu'en réalité c'est une colique biliaire, mais communément on l'appelle colique hépatique. Donc c'est une obstruction du canal cystique, c'est mécanique au début, tout au début du collet ou bien du canal cystique et avec la stase, la stase va favoriser l'apparition de l'infection et du contenu de la visicule biliaire.

Donc les complications qu'on peut imaginer, c'est lorsque le calcul ou bien la litiase s'enclave, se bloque au niveau du siphon de la visicule biliaire ou au niveau du canal cystique, elle va donner le tableau de l'hydrocolysiste. L'hydrocolysiste qui est une complication qui survient chez un patient qui est porteur d'un calcul de la visicule biliaire. C'est une complication mécanique et cet hydrocolysiste, il a la particularité que le patient va présenter une douleur, cette fois-ci qui est continue, c'est-à-dire ce n'est plus le patient qui a une douleur paroxystique de l'hypochondre droit qui cède après quelques minutes ou bien après 30 minutes avec les entalgiques, avec les antispasmodiques.

Cette fois-ci, le calcul il est bloqué au niveau du siphon ou bien au niveau du canal cystique et si le patient n'est pas opéré, l'évolution va se faire vers le pyrocolysiste qui est le stade ultime de l'évolution d'un hydrocolysiste. Le contenu de la visicule devient purulent, épais, on peut le voir à l'échographie. Sinon, l'hydrocolysiste s'accompagne d'un contenu clair, eau de roche, parce que ça correspond à la stase du mucus qui est sécrétée par la muqueuse de la visicule biliaire.

Et donc, dans l'hydrocolysiste, cliniquement déjà, il n'y a pas de température. La température est normale, ça c'est la particularité de cette complication. Par contre, dans le pyrocolysiste, le patient devient fébrile, il a un 38, 38,5, 39, voire même 40, donc le sepsis s'installe.

Cette litiase peut parfois franchir le canal cystique. Les calculs vont forcer le passage et passer dans la voie biliaire principale pour se compliquer de litiase de la voie biliaire principale. Cette fois-ci, les voies biliaires d'amont vont se dilater, et ça peut entraîner une infection de la bile dans les voies biliaires, et donc l'apparition d'ictères rétionnels, voire même l'apparition d'une complication assez sévère qui est l'angiolite litiastique.

Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui est très fréquente. 10 à 15 % de la population adulte développe des litiases de la visicule biliaire, avec un âge moyen de 40 à 60 ans. Une prédominance féminine s'explique essentiellement par les facteurs hormonaux.

Les oestrogènes favorisent le relâchement des fibres musculaires lisses, et donc favorisent la formation de litiases dans la visicule biliaire. Les facteurs alimentaires, on en a déjà parlé dans l'introduction, donc un régime hypercalorique, une mauvaise hygiène alimentaire peut entraîner une hypercholestérolémie, et donc l'apparition d'un déséquilibre dans la physiologie de la constitution de la bile. Mais aussi il y a des facteurs génétiques, des malformations de la visicule biliaire, des facteurs ratio.

Donc, il faut savoir que les calculs de la visicule biliaire se constituent toujours au niveau de la visicule biliaire. C'est-à-dire que les calculs retrouvés au niveau de la voie biliaire ont une origine. Le primordial mauvaise se trouve au niveau de la visicule biliaire.

La nature peut être, dans la majorité des cas, variable. Dans 80%, il s'agit d'associations de litiases d'origine cholestérolique, mais aussi pigmentaires. C'est essentiellement des bilirubinales de calcium, de cholestérol, plus ou moins opaques.

Le nombre est variable. Je reviens à l'histoire naturelle de la constitution d'un calcul. Un calcul ne démarre jamais à 2 cm.

Avant qu'il atteigne les dimensions de 2 cm ou 1 cm, ça veut dire qu'il a été millimétrique. On commence toujours par du sludge, par de la bile épaisse, une bile déshydratée. Jour après jour, les micro-litiases vont cristalliser, se concrétiser, se réunir les unes par rapport aux autres pour former de grosses litiases.

Le nombre peut être variable. On peut avoir un seul calcul, comme on va voir sur une échographie, comme on peut avoir une visicule avec de nombreux calculs, ce qu'on appelle un empiement de la visicule biliaire. Les dimensions sont variables, du petit calcul millimétrique inférieur à 1 mm jusqu'au gros calcul.

Parfois, toute la visicule se présente sous forme d'une visicule porcelaine calcifiée. La taille est variable. La paroi de la visicule biliaire, elle aussi, est très intéressante à étudier.

Une visicule normale, normalement, elle présente une paroi qui est mince, souple, brillante. Mais il faut savoir que si le patient est porteur d'un calcul dans sa visicule biliaire, et avec la répétition des crises de colicystite aiguë, surtout s'ils n'ont pas été pris en charge pour les traiter, jour après jour, la visicule va évoluer vers une colicystite sub-aiguë, ensuite une colicystite chronique, ensuite le volume va se rétrécir, donc une colicystite chronique veut dire que la visicule est de volume nettement inférieur et de taille nettement inférieure par rapport à une visicule qui est tout à fait normale. Pour les complications, la visicule distendue présente une paroi épaissie.

Normalement, la paroi mesurée à l'échographie ne dépasse pas les 3 millimètres, mais en cas de colicystite ou bien d'hydrocolicyste ou de pyocolicyste, la paroi devient supérieure aux 3 millimètres. On va voir ça dans quelques diapositives. Dans la colicystite chronique, on a une visicule sclérosée, atrophique, avec une sclérose des couches de la paroi.

C'est une évolution dans le temps d'un calcul négligé de crises à répétition, de crises de colicystite aiguë qui vont se résoudre spontanément et la visicule va se rétracter sur les calculs. Sinon, on peut avoir des complications historiques telles que la fistulisation dans les voies biliaires ou carrément la fistulisation dans le tube digestif. On va parler un peu d'une complication historique qui est l'hileus biliaire.

Heureusement, on ne voit plus ces complications. Le calcul peut se fistuliser dans la paroi du tube digestive et il peut passer depuis le siphon ou bien depuis la vésicule biliaire. Avec l'inflammation et les adhérences qui se créent avec le duodenum, il peut se créer une fistule entre la vésicule biliaire et le duodenum et un calcul centimétrique qui passe dans la lumière du tube digestive dans le duodenum va suivre le transit, il va descendre dans le jejunum.

Une fois arrivé au niveau de l'hileu, l'hileu a un calibre qui est moins important que le jejunum. Le calcul peut bloquer, il peut s'enclaver et entraîner un tableau d'occlusion intestinale aiguë qu'on appelle l'hileus biliaire. Heureusement, ces complications graves ne se voient plus.

Maintenant, avec l'installation des médecins, même au milieu rural, heureusement, les diagnostics sont faits et la prise en charge est faite. Donc, on voit de moins en moins, rarement, ces complications telles que l'hileus biliaire. Les tableaux anatomocliniques, la lithiase vésiculaire peut être asymptomatique.

C'est le cas le plus fréquent, dans 80 % des cas. Parfois, elle se manifeste par une douleur qu'on appelle la colique hépatique, donc une douleur de l'hypocondre droit, plus ou moins l'épigastre. Elle peut être déclenchée par un repas copieux, elle peut être intense, mais elle est surtout spasmodique, c'est-à-dire spontanément résolutive, même sans traitement, parfois avec des médicaments, des antalgiques, des antispasmodiques.

Donc, la colique hépatique, elle peut avoir une irradiation postérieure de quelques minutes, voire même de quelques heures. Elle peut s'accompagner parfois de vomissements ou de nausées, de troubles dyspeptiques, parfois de migraines. L'examen clinique, lorsque le patient se présente à la consultation, il est apéritique, dans le cas d'une lithiase vésiculaire simple, il n'y a pas d'ictère, l'hypocondre droit, il est libre, il n'y a pas de défense.

Parfois, on note une douleur, un signe de Murphy positif. Les examens complémentaires, en premier, il faut demander l'échographie abdominale. L'échographie abdominale, actuellement, n'est plus considérée comme un examen paraclinique, mais plutôt, c'est une extension de l'examen clinique, que tout médecin praticien doit savoir pratiquer, il doit savoir manipuler l'échographie abdominale.

Elle permet le diagnostic dans la majorité des cas. C'est un examen simple, sensible, de 90% jusqu'à 100%. Il renseigne sur la taille de la vésicule biliaire, sur la paroi, qui doit être inférieure aux 2 mm.

Cela sous-entend que la paroi de la vésicule biliaire est souple. Le contenu doit être normalement limpide, peu écho-gène. Mais quand il s'agit d'une lithiase de la vésicule biliaire ou d'une cholecystite, le contenu peut devenir hyper écho-gène, et la présence de calcul se manifeste par une image de chambre d'ombre postérieure.

Voici la chambre d'ombre postérieure à l'échographie. On voit ici l'épaisseur de la paroi.

Normalement, une paroi normale doit être inférieure à 2-3 mm.

Sinon, on peut voir ici la présence d'un seul calcul, avec la cambre d'ombre postérieure. Une autre patiente présente deux gros calculs avec une cambre d'ombre postérieure. L'examen de choix et de première intention, c'est l'échographie.

Les examens complémentaires tels que la cholecystographie ou la cholangiographie intraveineuses pour poser le diagnostic ne sont plus demandés aujourd'hui. Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec un ulcère gastro-duodénal ou bien une complication de l'arythmie de la vésicule qui est la pancréatite, d'où l'obligation de demander systématiquement le dosage d'une lipasémie. D'autres diagnostics différentiels à discuter devant une douleur de l'hypocampe droit, c'est une colique néphrétique.

La douleur est beaucoup plus intense, la maladie est agitée ou bien une douleur de type cardiaque. Il y a des engorgements dans leur forme abdominale. Les complications, il y a la cholecystite aiguë qui est l'inflammation et l'infection de la paroi de la vésicule et les secondaires à la stase et à l'obstruction de l'infundibulum ou bien du canal cystique.

Cliniquement, cette fois-ci, en plus de la douleur, elle devient prolongée. Elle ne cède pas après l'administration d'antalgiques. Elle bloque la respiration.

Les vomissements peuvent être alimentaires ou biliaires, mais essentiellement la température est supérieure à 38, 38,5. L'examen physique note une défense de l'hypocampe droit. L'abdomen n'est plus souple.

Parfois, ceci peut s'accompagner d'un ballonnement sur la paroi de l'abdomen. Le bilan sérologique, on peut demander une numération formule sanguine. En cas de cholecystite, on va noter une hyperleucocytose.

Les globules blancs sont supérieurs à 9000, voire même à 10 000, surtout à prédominance des polynucléaires. Le bilan hépatique doit être systématique dans ce cas-là. Et bien sûr, la lipasémie, comme on vient de le voir.

Le bilan hépatique, normalement, on demande les bilirubines, les phosphatases alcalines, les gamma-GT. Ce bilan hépatique dans la vésicule, dans une vésicule simple, ne doit pas montrer d'augmentation, c'est-à-dire de cholestase. Une échographie abdominale va confirmer le diagnostic de la cholecystite en montrant une paroi épaissie.

Parfois, elle peut atteindre une épaisseur considérable. Lorsqu'il s'agit d'une paroi dédoublée, parfois elle atteint les 10 mm. Les formes cliniques.

Les formes résolutives spontanément au sous-traitement médical sont les plus fréquentes. La douleur s'amende spontanément. L'évolution avec non-traité, non-traité, non-pris en charge, non-opéré, la lithiase finit toujours par évoluer vers une vésicule sclérotisante ou bien vers

l'apparition de complications graves, telles la pancréasite aiguë ou bien l'ongicolite.

Des formes plus graves peuvent s'observer chez des patients qui présentent, par exemple, un diabète. Le diabétique peut rapidement basculer vers une cholecystite gangréneuse, d'autant plus que la douleur n'est pas très importante chez les patients diabétiques. Je pense que devant tous les patients diabétiques chez qui on diagnostique une lithase vésiculaire, il vaut mieux conseiller aux patients d'aller se faire... Les autres complications, la cholecystite emphysemateuse, c'est la présence d'air dans la paroi de la vésicule biliaire, c'est des complications qu'on voit surtout chez les malades diabétiques.

Les signes locaux sont discordants, c'est-à-dire qu'il y a un contraste entre l'absence de signes cliniques très brouillants et la gravité du tableau clinique. Donc, non traité, la cholecystite peut évoluer vers d'autres complications telles que le plastring de la vésicule biliaire ou bien la présence de collections purulentes autour de la vésicule biliaire, sur le lit de la vésicule biliaire, parfois même dans le parenchyme hépatique. Une cholecystite ou bien une lithase de la vésicule biliaire peut se compliquer d'abcès hépatiques.

D'ailleurs, devant un abcès hépatique, le premier diagnostic auquel il faut penser, je pense, c'est l'éventuel lithase de la vésicule biliaire. Dans ce cas, le syndrome infectieux est assez net avec une fièvre élevée. L'échographie ou essentiellement le scanner montre la présence de collections et des signes de cholecystite.

Une complication assez grave qui est la péritonite biliaire. Un pur cholecyste non pris en charge, la vésicule peut se perforer et la bile va couler dans la grande cavité péritoniale et donner un tableau de cholepéritone, une péritonite biliaire. La péritonite biliaire, heureusement, est de moins en moins observée.

Encore une fois, grâce à la médicalisation de notre société. Le mécanisme, cette péritonite peut se faire en un seul temps, c'est-à-dire un tableau assez rapide. Parfois, c'est le passage par un plastring.

Parfois, c'est le grand entente qui vient colmater ce pur cholecyste et non pris en charge, finalement, peut se constituer la péritonite généralisée. La mortalité, dans ce cas, est assez lourde. Elle peut atteindre les 20 %. Les autres complications historiques, heureusement, qu'on voit de moins en moins, c'est la fistulisation.

On a parlé tout à l'heure de l'hidés biliaire, c'est-à-dire de ce calcul qui va passer à travers une fistule avec le diodénome et venir s'enclaver au niveau de l'hidéon et entraîner carrément un tableau d'occlusion intestinale aiguë, ou bien les fistules bilio-biliaires ou bien les fistules bilio-digestives. Donc, heureusement que ces complications sont devenues un peu rares, voire même exceptionnelles. La complication la plus fréquemment rencontrée, c'est l'hydrocolysyste, un calcul, et c'est une raison pour opérer toute lithase diagnostiquée.

Je pense qu'en observant ces complications telles que l'hydrocolysyste, le biocolysyste, la litiase de la voie biliaire principale, ou bien l'angiolite, ou bien la pancréasite aiguë, tout ceci, c'est des raisons pour opérer dans des meilleures conditions maintenant avec la cellulose, la litiase de la visicule biliaire. Et n'oublions pas, n'oublions pas, il n'y a pas une complication grave, inéluctable, d'un calcul qui a évolué pendant plusieurs années. Un jour, il va évoluer vers le calcul au cancer.

Le calcul au cancer, c'est un cancer très méchant, très mauvais, et le diagnostic, le plus souvent, il est fait à un stade tardif. Donc, il vaut mieux opérer avant l'apparition des complications des litiases de la visicule biliaire. Donc, les complications mécaniques les plus fréquemment rencontrées sont l'hydrocolysis, c'est-à-dire l'enclavement du calcul dans le collet, ou bien dans le cystique.

C'est un accident purement mécanique. Le contenu de la visicule biliaire est encore clair. D'ailleurs, on parle de bile blanche, mais en fait, ce n'est pas de la bile, c'est du mucus qui a stagné et qui ne peut plus circuler à travers le canal cystique pour descendre dans la voie biliaire dans le diodénome.

Donc, quand on opère un hydrocolysis vrai et on ouvre la visicule biliaire, on trouve plutôt de la bile blanche, c'est-à-dire du mucus. La visicule, en fait, elle est exclue, et même la bile ne pénètre plus cet hydrocolysis. Un point important, la température, elle est normale.

La visicule, elle est palpable à l'examen clinique de l'hypocondre droit. On sent une masse sous le rebord costal et à l'échographie, la visicule, elle est distendue. Sa paroi est eudématisée.

Elle dépasse les 2 à 3 mm et c'est une urgence. C'est une urgence à hospitaliser le patient pour l'opérer parce que la douleur, elle est continue, elle ne va pas s'aider et je pense qu'il faut, bien sûr, bilanter, mettre en condition ce patient qui a cette complication. Non prise en charge, au bout de 24-48 heures, l'hydrocolysis va évoluer vers une autre complication qui est le pyrocolysis.

Le pyrocolysis, en plus des signes dont on a parlé dans l'hydrocolysis, s'ajoute la température qui va commencer à grimper. Donc, on n'est plus asymptomatique, apéritique. On a un 38, 38,5, voire même un 39, voire même un 40 degrés.

Le contenu, il n'est plus clair, haute roche, mais il devient de plus en plus purulent. C'est un ampième de la visicule biliaire. C'est une stagnation du pus à l'intérieur de la visicule biliaire.

La visicule est distendue avec à l'échographie sa paroi. Là aussi, c'est une urgence. Il faut hospitaliser le patient pour le bilanter, pour éliminer d'autres complications qui peuvent s'associer.

Notamment, je pense à la pancréasite aiguë. Donc, la demande de la liposémie doit être systématique pour ne pas se faire avoir et aller opérer une pancréasite aiguë à la phase chaude. Les complications à long terme, c'est le cancer de la visicule biliaire.

C'est le cinquième cancer digestive. Il est très grave. Il se développe presque toujours sur une lithiase de la vésicule biliaire.

Donc, une lithiase asymptomatique négligée, encore une fois, je pense qu'il faut l'opérer, ne serait-ce que pour éviter le calcul au cancer. On ne parle pas des complications qu'on vient de voir, l'hydrocolysis, le pyrocolysis, l'angiolite. Non, opérer, les calculs sont toujours là.

Ils ne vont jamais disparaître une fois qu'ils sont formés. Donc, le calcul au cancer est découvert sur pièce de colicystectomie dans 2 %. Alors, c'est très important. Chaque fois qu'on opère une lithiase de la vésicule biliaire et on pratique la colicystectomie, il faut obligatoirement et systématiquement adresser la pièce au laboratoire d'anatomopathologie pour découvrir ou bien éliminer la présence d'un calcul au cancer.

Dans notre contexte, malheureusement, on diagnostique le calcul au cancer à un stade tardif, un stade de masse dictée par envahissement de la voie biliaire principale. Les autres complications sont, dans 10 %, la migration de calculs à travers le canal cystique dans la voie biliaire principale. Ça peut être asymptomatique.

Le malade peut être asymptomatique quand il peut présenter un syndrome infectieux. On sait très bien que la stase va favoriser la surinfection et donc l'apparition du tableau d'angiolite. Donc, c'est une succession de colics hépatiques.

La température est à 39 jusqu'à 40 degrés Celsius avec frissons et c'est le tableau d'un lecteur rétionnel qui est variable. C'est très important, le terme variable. Variable, il nous permet déjà, au stade d'interrogatoire, de reconnaître et de savoir est-ce que, parce que le problème devant un lecteur rétionnel, c'est de craindre la hantise du médecin et du chirurgien, c'est de craindre la présence d'une tumeur qui explique ce lecteur rétionnel.

Donc, le fait que le lecteur s'améliore au cours des jours, au cours des semaines et reprend, est un élément en faveur d'un obstacle mobile, c'est-à-dire de la lithiase et non pas d'un obstacle tumoral. Avec l'obstacle tumoral, le lecteur est constant. Il ne s'améliore pas au cours des jours et au cours des semaines.

L'examen physique, donc, en cas d'angiolite, va retrouver le lecteur, des téguments, une sensibilité de l'hypochondre droit. Parfois, on a un gros foie, un hépatomegalie, un foie de stase. Et le risque d'évoluer vers une insuffisance organique.

L'empirement collédosien se définit par la présence de plus de 10 lithiases dans la voie biliaire principale. D'autres tableaux cliniques, ce sont les calculs résiduels chez un malade déjà opéré pour une lithiase de la vésicule biliaire, c'est-à-dire cholecystectomisée. Et donc, il faut savoir rechercher les calculs résiduels dans la voie biliaire principale.

Le traitement, il repose essentiellement sur... Le but, c'est de traiter la lithiase et ses

conséquences. Il y a des moyens médicaux pour calmer la douleur par les antispasmodiques, les antiémétiques, les antibiotiques. Les traitements n'ont plus de place.

Ils sont parfois dangereux, tels que... la litotricie externe. Le fait de fragmenter le calcul peut entraîner des microlithiases qui vont franchir le canal cystique et déclencher une pancréasite aiguë. Donc, médicaments dissolvant litotricie n'ont plus de place actuellement.

Actuellement, le traitement de la lithiase de la vésicule biliaire et la cholecystectomie par voie sélioscopique. C'est le gold standard. On peut avoir recours à la cholydocotomie pour traiter une lithiase de la voie biliaire principale qui, l'intervention, va se terminer soit par un drain de caire qu'on va laisser dans la voie biliaire principale.

Le drain de caire, c'est un drain siliconé, souple, qui a la particularité de permettre une cicatrisation tout autour pour éviter une fuite biliaire au niveau de la cholydocotomie. Sinon, on peut terminer la cholydocotomie par un drainage biliaire, c'est-à-dire une dérivation entre le cholydoc et le tube digestif. D'autres moyens thérapeutiques existent.

C'est la collongographie et la sphinctérotomie avec ablation des calculs. C'est une technique qui s'est bien développée, même ici à Marrakech. Il y a beaucoup de grands frères gastroenterologues qui pratiquent cette technique.

L'indication idéale, c'est lorsqu'il y a des calculs de la voie biliaire avec des lithiases de la vésicule biliaire. Une coopération entre les équipes est souhaitable pour le traitement du lithiase de la vésicule biliaire. On peut commencer par la sphinctérotomie et le cathétérisme de la voie biliaire.

On extrait les calculs par voie endoscopique et l'équipe chirurgicale prend le relais pour faire la cholecystectomie et éviter au patient une laparotomie par voie sous-costale. Les indications, c'est le traitement médical pour soulager la douleur, le régime, le repos, la cholecystectomie sélioscopique, encore une fois, c'est le gold standard. Parlons des avantages de la sélioscopie.

L'avantage esthétique, l'absence de douleur ou peu de douleur, le lever précoce, l'hospitalisation très courte, donc tout ceci explique pourquoi la cholecystectomie sélioscopique est le gold standard. Voici une vue des trocars lors d'une cholecystectomie sélio avec l'opérateur. Le chirurgien va placer ces trocars pour créer d'abord un espace de travail dans la cavité péritoneale insufflée de l'air, essentiellement du CO₂, pour distendre la cavité péritoneale et pouvoir travailler et faire la cholecystectomie.

La cholecystite aiguë, normalement, c'est le traitement médical, les antibiotiques et la cholecystectomie dans la foulée ou bien après 48 heures. Pour la lithiase de la voie biliaire, c'est la coopération entre le chirurgien et le gastroenterologue pour pratiquer ce qu'on appelle le full endoscopie, la sphinctérotomie plus la cholecystectomie par voie sélioscopique. En conclusion, on va dire que c'est une pathologie qui est très fréquente.

20% de la population présente une lithiase de la vésicule biliaire, d'où la nécessité que tout médecin praticien doit savoir la diagnostiquer et savoir gérer le traitement. C'est une pathologie qui peut avoir des complications graves, mortelles même, telles que l'angiocholite, la pancréatite et à long terme le calcul au cancer. Le traitement est essentiellement chirurgical.

Je vous remercie.